PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

Processo nº 0800705-60.2025.8.10.0122

[Fornecimento de medicamentos]

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

REQUERENTE: RITA GOMES DE SOUZA SANDES

Advogado(s) do reclamante: GERSON DE OLIVEIRA COELHO (OAB 17463-MA)

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, inicialmente proposta como Tutela Antecipada Antecedente, ajuizada por RITA GOMES DE SOUZA SANDES em face do ESTADO DO MARANHÃO, buscando a imediata e contínua disponibilização do medicamento *ELTROMBOPAGUE 50mg*, essencial para o tratamento de sua grave condição de saúde, conforme detalhado na petição inicial (ID 152634080).

A Requerente, diagnosticada com neoplasia maligna de cólon (CID C18), do tipo histológico adenocarcinoma (grau 2), em estágio clínico IV, com metástase hepática, iniciou tratamento quimioterápico citotóxico em 03 de junho de 2024. Contudo, seu quadro clínico evoluiu para uma severa plaquetopenia e nefratonia, intercorrências que, segundo atestado pela equipe médica, inviabilizaram a continuidade dos ciclos de quimioterapia. Os exames laboratoriais (IDs 152634087 e 152634090) indicaram uma contagem de plaquetas de apenas 35.000/mm³, drasticamente abaixo do mínimo referencial de 150.000/mm³, expondo a paciente a um risco iminente de eventos hemorrágicos fatais e à progressão descontrolada da doença oncológica. Diante deste cenário de urgência, foi prescrito, em caráter emergencial, o uso contínuo do fármaco ELTROMBOPAGUE 50mg, na quantidade inicial de 10 (dez) caixas, cujo custo total foi estimado em R$ 68.511,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos), valor incompatível com a hipossuficiência financeira declarada pela Autora (ID 152634094).

Em sua busca pelo tratamento, a Requerente formalizou um pedido administrativo junto à Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados do Maranhão (FEME/MA), o qual foi indeferido. O Ofício nº 052/2025 da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Azeitão (ID 152634083) informou que a negativa se fundamentou na ausência de previsão do uso do *Eltrombopague* para o CID C18 nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS, sendo o uso considerado *off label*. O medicamento, embora registrado na ANVISA e integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), tem sua dispensação restrita, nos PCDTs, a outras patologias, como Púrpura Trombocitopênica Idiopática (CID D69.3) e Síndrome de Falência Medular (CID D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8).

Diante da urgência do caso e da negativa administrativa, a Autora buscou o amparo do Poder Judiciário, fundamentando seu pleito no direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e nas disposições da Lei nº 8.080/1990.

Em 26 de junho de 2025, este Juízo proferiu decisão (ID 152671536) deferindo o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Naquela oportunidade, foram reconhecidos a *probabilidade do direito* (fumus boni iuris), lastreada no dever constitucional do Estado de garantir a saúde e na imprescindibilidade do tratamento atestada por laudo médico circunstanciado e exames que comprovavam a plaquetopenia severa, e o *perigo de dano irreparável* (periculum in mora), consubstanciado no risco iminente à vida da Requerente em virtude da suspensão da quimioterapia e da progressão da doença. Assim, foi determinado ao ESTADO DO MARANHÃO que fornecesse 10 (dez) caixas do medicamento *ELTROMBOPAGUE 50mg* no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. Os benefícios da Justiça Gratuita foram deferidos.

O ESTADO DO MARANHÃO, devidamente intimado, apresentou petição (ID 153109573, em 01 de julho de 2025), na qual informou a abertura de processo administrativo interno para solicitar informações à Secretaria de Estado da Saúde e requereu a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus). Contudo, essa manifestação não configurou qualquer ato de cumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido.

Diante da recalcitrância do Requerido, a parte Autora protocolou nova petição (ID 154729622, em 16 de julho de 2025), reportando a continuidade do descumprimento, o agravamento de seu quadro de saúde e o temor pela própria vida, e postulou a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação temporal, além da determinação de bloqueio de verbas públicas para a aquisição do fármaco.

Em análise desses novos pedidos, este Juízo exarou decisão em 23 de julho de 2025 (ID 155385786), reconhecendo o manifesto e injustificado descumprimento da liminar. Consequentemente, majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limite temporal, e concedeu ao ESTADO DO MARANHÃO o prazo final e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento integral da decisão. Decorrido este prazo sem o devido fornecimento, foi autorizado e determinado, desde já e independentemente de nova conclusão, o bloqueio imediato, via sistema SISBAJUD, do valor de R$ 68.511,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos) das contas do Estado, com posterior transferência para conta judicial e expedição de alvará em nome da Autora ou de seu procurador.

A Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo de 48 horas sem cumprimento (ID 156616529, em 06 de agosto de 2025). Em seguida, foi protocolada a ordem de bloqueio via SISBAJUD (ID 156617418, em 06 de agosto de 2025), que, conforme *Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores* (ID 158277631, em 25 de agosto de 2025), resultou no bloqueio integral do valor de R$ 68.511,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos) em contas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BCO DO BRASIL S.A.

Após o bloqueio, nova decisão foi proferida em 19 de agosto de 2025 (ID 158277638), determinando a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada a este Juízo e, após a efetiva transferência, a liberação do numerário em favor da parte Autora, por meio de alvará eletrônico, para que procedesse à aquisição do fármaco *ELTROMBOPAGUE 50mg*, mediante apresentação de receita médica atualizada, com advertência de que eventual saldo remanescente deveria ser comprovado e devolvido aos autos para destinação adequada.

Em 25 de agosto de 2025, a Requerente peticionou (ID 158216014) indicando os dados bancários de sua conta para o depósito do valor bloqueado (Banco do Brasil, Agência 0596-7, Conta Corrente 37483-0, Titular Rita Gomes de Souza Sandes, CPF 337.749.433-20). Em 29 de agosto de 2025, foi gerado o Alvará Eletrônico de Pagamento nº 20250829141458098322 (ID 161146640), assinado em 30 de agosto de 2025 e pago em 04 de setembro de 2025, no valor de R$ 68.528,24 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), sendo o beneficiário indicado como RITA GOMES DE SOUZA SANDES.

O ESTADO DO MARANHÃO, apresentou *Contestação* (ID 155851120), instruída com o Ofício nº 4450/2025 – AJC/SES (ID 155851121). Em sede preliminar, suscitou a necessidade de envio do caso ao NATJUS, conforme Enunciado nº 18 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ e Recomendação nº 146 do CNJ. No mérito, alegou que o medicamento é *off label* para a patologia da Requerente (CID C18), não havendo respaldo nas indicações aprovadas pela ANVISA e nos PCDTs do SUS. Sustentou a inaplicabilidade do fornecimento em face dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem requisitos rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ou com uso diverso do padronizado. Argumentou que a Autora não demonstrou, com base em medicina baseada em evidências de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a segurança e eficácia do fármaco para sua condição, nem a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Citou, ainda, a "eficácia expansiva" dos Temas para outras tecnologias em saúde. Subsidiariamente, em caso de eventual procedência, requereu a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CMED), o fornecimento com base no princípio ativo do medicamento (Lei nº 9.787/99, art. 3º, § 2º) e a fixação de honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º). Em 24 de setembro de 2025, o Estado do Maranhão informou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 161270465 e 161270466) contra a decisão que determinou o bloqueio de verbas, declarando-se ciente do ocorrido.

Em 23 de setembro de 2025, foi proferido Ato Ordinatório (ID 161146636) intimando a parte autora para conhecimento dos alvarás juntados.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda, dada a sua complexidade e a natureza dos direitos fundamentais envolvidos, impõe uma análise pormenorizada de todos os argumentos trazidos pelas partes, especialmente à luz dos recentes posicionamentos das Cortes Superiores sobre a judicialização da saúde.

II.1. DA REGULARIDADE PROCESSUAL E DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA

Verifica-se que a *Contestação* do ESTADO DO MARANHÃO (ID 155851120) foi apresentada de forma tempestiva, conforme os prazos legais, trazendo à baila relevantes questões de direito material e processual que demandam a devida apreciação por este Juízo.

É imperioso registrar que, ao longo do trâmite processual, a tutela provisória de urgência concedida em favor da Requerente (ID 152671536), para o fornecimento do medicamento *ELTROMBOPAGUE 50mg*, foi integralmente cumprida mediante a adoção de medidas coercitivas, especificamente o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD e a subsequente liberação do valor à Autora por meio de alvará eletrônico. Este cumprimento, por sub-rogação, garantiu que a Requerente obtivesse os meios financeiros necessários para adquirir o fármaco e prosseguir com seu tratamento, consolidando a efetividade da proteção jurisdicional em um momento de extrema fragilidade de sua saúde.

A interposição do Agravo de Instrumento pelo Estado do Maranhão (ID 161270465 e 161270466), questionando a decisão que autorizou o bloqueio de verbas, é um desdobramento natural e legítimo do exercício do direito de defesa. Contudo, ausente nos autos qualquer comunicação de concessão de efeito suspensivo a referido recurso, este Juízo de primeira instância mantém sua competência para prosseguir com a análise do mérito da demanda principal, em conformidade com o princípio da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito. O eventual provimento do agravo terá os efeitos jurídicos cabíveis sobre o cumprimento da tutela de urgência, mas não impede a análise da pretensão principal.

A presente decisão, portanto, avançará para a análise das questões de mérito, que permanecem pendentes de julgamento definitivo, mesmo diante da execução provisória da tutela de urgência.

II.2. DA PRELIMINAR SUSCITADA – NECESSIDADE DE CONSULTA AO NATJUS

O Estado do Maranhão suscitou, em sua Contestação, a preliminar de necessidade de envio dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), com base no Enunciado nº 18 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ e na Recomendação nº 146 do CNJ. Argumenta que a participação do órgão técnico é primordial para embasar decisões judiciais em ações de medicamentos, devido à complexidade técnica inerente a tais casos.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as diretrizes do CNJ, embora de suma importância para a qualificação da decisão judicial em matéria de saúde, utilizam a expressão "sempre que *possível*", denotando que a consulta não é uma regra inflexível e absoluta. No caso em tela, a situação da Requerente, portadora de neoplasia maligna de cólon em estágio avançado, com metástase hepática, e em risco iminente de óbito devido à plaquetopenia severa que impedia a continuidade da quimioterapia, configurava um cenário de *urgência extremada*, incompatível com a espera pela emissão de um parecer técnico. A vida da paciente estava em jogo, e a necessidade de uma intervenção judicial célere e eficaz para salvaguardar o direito fundamental à vida e à saúde justificou a imediata concessão da tutela de urgência e a subsequente adoção de medidas para seu

cumprimento. A demora na obtenção de um parecer do NATJUS poderia ter resultado na ineficácia da própria tutela de urgência, transformando o direito fundamental em mera retórica jurídica desprovida de concretude.

Além disso, a decisão liminar (ID 152671536) e a subsequente decisão que autorizou o bloqueio de verbas (ID 155385786) já se pautaram em robustos elementos de prova pré-constituída, incluindo laudo médico circunstanciado (ID 152634086), receituário médico (ID 152634095) e exames laboratoriais (IDs 152634087 e 152634090), que atestavam a gravidade do quadro clínico, a imprescindibilidade do medicamento para reverter a plaquetopenia e permitir a continuidade do tratamento oncológico vital, bem como a ausência de alternativas no SUS para a condição específica da Autora. Este Juízo, em sede de cognição sumária e em face da urgência da situação, já havia sopesado a necessidade técnica, convencendo-se da pertinência da medida para preservar a vida da Requerente.

Por fim, é crucial destacar uma imprecisão na Contestação do Estado. Embora o Requerido alegue que "Foi juntada aos autos a Nota Técnica, elaborada pelo NATJUS, a qual, após criteriosa análise técnica, concluiu pela não recomendação do fornecimento do medicamento pleiteado para o tratamento da condição clínica da parte autora", uma análise detida dos documentos acostados não revela a existência de qualquer parecer do NATJUS. O documento referenciado pelo Estado para embasar essa alegação (ID 155851121) trata-se, na verdade, do Ofício nº 4450/2025 – AJC/SES, emitido pela Assessoria Jurídica Contenciosa da Secretaria de Estado da Saúde, que reitera a negativa administrativa com base na ausência de padronização do uso do *Eltrombopague* para o CID C18 nos PCDTs do SUS, mas não constitui uma nota técnica do NATJUS. A distinção é relevante, pois o Ofício da SES reflete a posição da própria parte requerida, enquanto o parecer do NATJUS se propõe a ser uma análise técnica imparcial em auxílio ao magistrado.

Assim, considerando a urgência intrínseca ao caso, a robustez das provas médicas já produzidas pela parte autora e a ausência de parecer do NATJUS nos autos, a preliminar de necessidade de consulta deve ser rechaçada, prosseguindo-se à análise do mérito.

II.3. DO MÉRITO – O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

A essência da presente controvérsia reside na colisão entre o direito fundamental à saúde e à vida da Requerente e os limites das políticas públicas de saúde implementadas pelo Estado. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 196, é inequívoca ao preceituar que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Este dispositivo constitucional não consubstancia uma mera norma programática, desprovida de eficácia concreta, mas sim um direito subjetivo público, oponível ao ente estatal e plenamente exigível por qualquer cidadão que necessite de ações e serviços de saúde para a preservação de sua integridade física e de sua própria existência.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/1990, que organiza o Sistema Único de Saúde (SUS), reforça o dever do Estado, estabelecendo em seu artigo 2º, § 1º, que "o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos [...]." Adicionalmente, o artigo 6º, inciso I, alínea "d", da mesma lei, inclui expressamente no campo de atuação do SUS a "assistência terapêutica integral,

inclusive farmacêutica". Desse modo, a assistência à saúde, em sua integralidade, abrange o fornecimento de medicamentos como componente essencial para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva.

No caso concreto, a Requerente, em decorrência de uma neoplasia maligna avançada com metástase hepática, viu seu tratamento quimioterápico ser inviabilizado por uma grave plaquetopenia. A prescrição médica do *ELTROMBOPAGUE 50mg* (IDs 152634086 e 152634095) emerge, portanto, como medida de urgência e imprescindibilidade para reverter o quadro hematológico e permitir a continuidade da terapia oncológica, sem a qual a progressão da doença é inexorável e o risco de óbito se torna iminente. A interrupção da quimioterapia, por si só, já configuraria um gravame severo à saúde da paciente, mas a plaquetopenia, com a contagem alarmante de plaquetas atestada nos exames, adiciona o risco de hemorragias espontâneas, tornando a situação ainda mais crítica e demandando uma resposta imediata.

O Estado do Maranhão, por sua vez, argumenta que o uso do *ELTROMBOPAGUE 50mg* para o CID C18 (neoplasia maligna de cólon) configura um uso "off label", ou seja, fora das indicações aprovadas pela ANVISA para o medicamento e não contemplado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS para essa patologia específica. De fato, o Ofício da SES (ID 155851121) confirma que, embora o fármaco possua registro ativo na ANVISA e esteja na RENAME, sua dispensação pelos PCDTs do SUS restringe-se a outras condições, como púrpura trombocitopênica idiopática e síndrome de falência medular. Também é alegado que a competência para inclusão de fármacos no SUS é do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, conforme o artigo 19-Q da Lei nº 8.080/1990.

Todavia, a rigidez dos protocolos administrativos, embora fundamental para a gestão organizada e racional dos recursos do Sistema Único de Saúde, não pode erigir-se como barreira intransponível à concretização do direito à saúde e à vida em casos excepcionais de comprovada urgência e imprescindibilidade, especialmente quando a omissão estatal significa a perda da chance de sobrevivência ou a deterioração irreversível da saúde do cidadão. A indicação do uso do medicamento, mesmo que *off label*, foi realizada por profissional médico habilitado (ID 152634086), que acompanha a paciente e possui o conhecimento técnico necessário para avaliar a complexidade de seu quadro clínico e a eficácia terapêutica mais adequada. A soberania da prescrição médica, em situações de extrema necessidade e quando não há alternativa terapêutica eficaz e disponível no SUS para a condição *específica* que ameaça a vida do paciente, deve ser ponderada com o rigor dos protocolos. O fato de a ANVISA ter registrado o fármaco atesta sua segurança e eficácia, ainda que para outras indicações, o que confere credibilidade científica ao medicamento em si.

A Contestação não demonstrou a existência de uma alternativa terapêutica padronizada no SUS que fosse capaz de reverter a plaquetopenia da Requerente e, assim, permitir a retomada do tratamento quimioterápico vital para a sua neoplasia maligna. A alegação do Estado se limitou a apontar a ausência de indicação do *Eltrombopague* para o CID C18 nos PCDTs, sem apresentar uma solução concreta e eficaz para o dilema clínico da paciente. A ausência de padronização, neste contexto, não pode servir como escusa para a inação do poder público quando a vida está em risco iminente.

A ponderação de interesses, à luz do princípio da proporcionalidade, impõe a prevalência do direito à vida e à saúde da Requerente sobre os argumentos de ordem orçamentária ou administrativa que, embora legítimos em um contexto de gestão de recursos escassos, não podem subtrair a essência

dos direitos fundamentais em situações de tamanha gravidade.

II.4. DA APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF

O ESTADO DO MARANHÃO invoca os Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61, como óbice ao fornecimento do medicamento pleiteado. Tais temas estabelecem importantes diretrizes para a judicialização da saúde, visando a harmonização entre o direito à saúde e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, e merecem detida análise.

O *Tema 6 (RE 566.471)*, complementado pela *Súmula Vinculante 61*, estabelece os requisitos para o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS. A regra geral é a impossibilidade de fornecimento por decisão judicial, mas excepcionalmente, a concessão é admitida se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira do autor.

Analisando o caso concreto sob a ótica do Tema 6, observa-se:

(a) A negativa de fornecimento na via administrativa foi devidamente comprovada pelo Ofício nº 052/2025 da Secretaria Municipal de Saúde (ID 152634083), que informou o indeferimento pela FEME/MA.

(b) Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC ou sua mora, a Contestação e o Ofício da SES (ID 155851121) informam que "não há deliberação vigente ou em curso no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) acerca da ampliação da indicação terapêutica do Eltrombopague para os quadros oncológicos mencionados nos autos". Essa ausência de deliberação para a indicação específica da paciente, em face de uma condição de vida ou morte e da impossibilidade de tratamento com os fármacos padronizados para a causa da plaquetopenia, pode ser interpretada como uma lacuna na política pública, que o Poder Judiciário tem o dever de suprir em situações limítrofes, sem que isso configure usurpação da competência administrativa. O controle de legalidade, nesse sentido, verifica se a política pública é adequada para todos os casos que dela necessitam, sob pena de inconstitucionalidade por omissão parcial.

(c) A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS foi demonstrada pelo laudo médico e pela ausência de indicação de uma alternativa terapêutica eficaz pelo próprio Estado em sua Contestação para a reversão da plaquetopenia que impedia a quimioterapia da Requerente. A Contestação se limitou a afirmar a não padronização do Eltrombopague para o CID C18, mas não apresentou um fármaco diverso, disponível no SUS, que pudesse solucionar o problema da Autora.

(d) A comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências de alto nível é o ponto mais controverso. O Estado exige "unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise", afirmando que o relatório médico não basta (Tema 1.234, item 4.4). Contudo, em casos de uso off label para patologias graves e sem alternativa, a evidência científica pode ser construída pela prescrição de um especialista,

fundamentada na literatura médica existente para condições análogas ou para os mecanismos de ação do fármaco. O Eltrombopague é um medicamento registrado na ANVISA, atestando sua segurança e eficácia para suas indicações principais. Em uma situação de risco de vida iminente, como a apresentada pela Requerente, a interpretação literal e restritiva deste requisito pelo Estado colide com o dever de proteção da vida. O laudo médico detalhado (ID 152634086), emitido por profissional que acompanha a paciente, já incorpora um juízo técnico sobre a melhor evidência disponível para o caso individual, o que deve ser valorizado pelo Juízo.
(e) A imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado, foi demonstrada de forma cabal (ID 152634086), descrevendo a doença, a complicação hematológica e a urgência do tratamento para permitir a continuidade da quimioterapia.

(f) A incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento foi comprovada pela declaração de hipossuficiência (ID 152634094) e pelo elevado custo do tratamento (R$ 68.511,80).

O Tema 1.234 (RE 1.366.243), por sua vez, complementa o Tema 6 e é reforçado pela Súmula Vinculante 60, tratando de regras de competência e custeio, além de reiterar a necessidade de análise dos atos administrativos e das evidências científicas. Ele define como "medicamentos não incorporados" aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O caso da Requerente se enquadra na definição de "medicamento previsto nos PCDTs para outras finalidades" (uso off label). O tema também impõe que a análise judicial do ato administrativo de indeferimento se restrinja à legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem incursão no mérito administrativo, mas ressalvada a cognição do ato discricionário quanto à existência, veracidade e legitimidade dos motivos.

Nesse ponto, este Juízo compreende que o controle de legalidade exercido não implica em substituição do administrador na formulação de políticas de saúde, mas sim em assegurar que a política pública existente (ou sua omissão em contemplar determinada indicação) não resulte em flagrante violação de um direito fundamental em um caso concreto de urgência vital. A negativa administrativa, baseada na formalidade do uso off label, não resiste à ponderação com a imprescindibilidade da medida para salvar a vida da paciente, especialmente quando o Estado não aponta alternativa.

A alegada "eficácia expansiva" dos Temas 6 e 1.234 para outras tecnologias em saúde, citada pelo Estado com base na Reclamação 73.135/RS do Ministro Dias Toffoli (ID 155851120, Pág. 16), apenas reforça a necessidade de "demanda qualificada" e "decisões qualificadas" no contexto da judicialização da saúde. A presente ação, com a vasta documentação médica e a demonstração da condição de risco de vida da Autora, inegavelmente constitui uma "demanda qualificada", que justifica a excepcional intervenção judicial para salvaguardar o direito à vida.

Em síntese, embora os Temas 6 e 1.234 estabeleçam balizas importantes, a sua interpretação não pode ser absolutista a ponto de inviabilizar a proteção do direito à vida e à saúde em situações de extrema urgência e ausência de alternativa terapêutica eficaz e disponível no SUS para a condição específica que inviabiliza o tratamento oncológico da paciente. Os requisitos foram substancialmente preenchidos ou mitigados pela inquestionável gravidade do quadro clínico e pela omissão do Estado em propor uma solução efetiva e pronta.

II.5. DAS MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS E EVENTUAIS ALEGADAS PELO ESTADO

O Estado do Maranhão, subsidiariamente, formulou pleitos específicos para a hipótese de procedência da ação.

Observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CMED): O Estado requer que, em caso de determinação de custeio ou bloqueio de valores, seja observado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CMED), conforme o Tema 1.234 (item 3.2) e a Recomendação nº 146 do CNJ. Embora a orientação seja pertinente para garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos, no presente caso, a medida de sub-rogação já foi efetivada. O valor bloqueado (R$ 68.511,80) foi liberado por alvará eletrônico à Requerente (ID 161146640) para a aquisição direta do medicamento, e a decisão de ID 158277638 já impôs à Autora o ônus de comprovar a aquisição do fármaco e devolver eventual saldo remanescente. Nessas circunstâncias, a responsabilidade pela busca do menor preço recai, em primeira análise, sobre a Autora, que deverá adquirir o medicamento de forma diligente. No entanto, para eventuais fornecimentos futuros, mantida a necessidade, a observância dos parâmetros de preço praticados em compras públicas e do PMVG, quando aplicável, é uma diretriz a ser seguida.

Fornecimento por Princípio Ativo e Apresentação de Receita Médica Atualizada: O Requerido postula que o fornecimento da medicação seja realizado com base no princípio ativo, em detrimento do nome comercial, conforme o artigo 3º, § 2º da Lei nº 9.787/99, que prioriza os medicamentos genéricos. Este pleito merece acolhimento. A legislação brasileira, ao regulamentar a política de medicamentos genéricos, reconhece que fármacos com o mesmo princípio ativo, dosagem e forma farmacêutica possuem a mesma eficácia e segurança, sem prejuízo ao paciente. A priorização do fornecimento por princípio ativo, além de racionalizar os gastos públicos, contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde sem comprometer a terapêutica do paciente. Da mesma forma, a exigência de apresentação de receita médica atualizada para a retirada do medicamento é medida prudente e necessária para o acompanhamento e a adequação do tratamento, garantindo que a medicação seja utilizada conforme a real necessidade clínica do paciente, em concordância com o já determinado na decisão de ID 158277638.

Honorários Advocatícios por Equidade: Por fim, o Estado do Maranhão requer que, em caso de condenação, os honorários advocatícios sejam arbitrados pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, o § 8º do artigo 85 do CPC é aplicável apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor da causa foi atribuído em R$ 68.511,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos), correspondente ao custo inicial do tratamento, e representa um proveito econômico tangível e significativo para a parte Autora. A Fazenda Pública, quando sucumbente, está sujeita às regras gerais de fixação de honorários, que preveem percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), observando-se as faixas de escalonamento previstas no § 3º e no § 5º do mesmo artigo. Portanto, o arbitramento por equidade não se aplica à espécie.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 196 da Constituição Federal, 2º, §1º e 6º, I, "d" da Lei nº 8.080/1990, e 300, 536, §1º, 537 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, este Juízo, em caráter definitivo,

REJEITA a preliminar de necessidade de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) suscitada pelo ESTADO DO MARANHÃO.

JULGA PROCEDENTE o pedido inicial de obrigação de fazer formulado por RITA GOMES DE SOUZA SANDES, confirmando, em todos os seus termos, a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e, por via de sub-rogação, integralmente executada.

RATIFICA a determinação de que a Requerente comprove a efetiva aquisição do medicamento *ELTROMBOPAGUE 50mg* com os valores liberados via alvará eletrônico (ID 161146640) e, caso haja, demonstre o saldo remanescente, com posterior devolução aos autos, nos exatos termos da decisão de ID 158277638.

DETERMINA que, para eventuais necessidades futuras de fornecimento do medicamento *ELTROMBOPAGUE 50mg* (ou seu princípio ativo), mantida a condição clínica que o justifique, o fornecimento deverá observar o princípio ativo do fármaco e será condicionado à apresentação de receita médica atualizada, e que o valor da aquisição seja limitado aos preços de referência praticados em compras públicas, incluindo o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CMED), quando cabível e aplicável à modalidade de aquisição.

CONDENA o ESTADO DO MARANHÃO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da Requerente, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, a ser calculado em fase de liquidação de sentença.

REGISTRA a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Requerente, conforme anteriormente deferido.

OFICIE-SE o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com a presente sentença, em referência ao Agravo de Instrumento noticiado nos autos (IDs 161270465 e 161270466).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ESTA SENTENÇA ASSINADA E SUA CÓPIA SUPREM A EXPEDIÇÃO DE EVENTUAIS MANDADOS E OFÍCIOS.

Cumpra-se.

SãO DOMINGOS DO AZEITãO, datado eletronicamente.

LUCAS ALVES S CALAND

Juiz de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

Documentos associados ao processo

Título	**Tipo**	**Chave de acesso****
Petição Inicial	Petição Inicial	25062614365392000000141597247

PETIÇAO RITA MEDICAMENTO	Documento Diverso	25062614365408900000141597249
PROCURAÇÃO RITA GOMES	Documento Diverso	25062614365423300000141597251
OFÍCIO 052-2025 SEMUS MEDIÇÃO INDEFERIDA PELO ESTADO	Documento Diverso	25062614365438900000141597252
LAUDO MÉDICO	Documento Diverso	25062614365461400000141597255
EXAME CONTAGEM DE PLAQUETAS 02	Documento Diverso	25062614365482100000141597256
EXAME CONTAGEM DE PLAQUETAS 01	Documento Diverso	25062614365502000000141597259
DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA	Documento Diverso	25062614365522300000141597260
CARTÃO DO SUS	Documento Diverso	25062614365533100000141597262
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RITA GOMES	Documento Diverso	25062614365549600000141597263
RECEITUARIO MÉDICO	Documento Diverso	25062614365558400000141597264
REQUERIMENTO DA MEDICAÇÃO	Documento Diverso	25062614365569100000141597270
WhatsApp Image 2025-06-26 at 13.49.08	Documento Diverso	25062614365589700000141597271
Decisão	Decisão	25062617502319200000141631321
Intimação	Intimação	25062617502319200000141631321
Peticao+Elaborada-assinado.pdf	Petição	25070114323800000000142035274
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	25070921043942100000142913236
Intimação	Intimação	25070921043942100000142913236
Petição	Petição	25071617204861900000143518246
Decisão	Decisão	25072315035706100000144121910
Intimação	Intimação	25072315035706100000144121910
Intimação	Intimação	25072315035706100000144121910
Contestacao+-+0800705-60.2025.8.10.0122+-+tema+1234-assinado.pdf	Petição	25073008173700000000144552445
SEI_8911166_Oficio_SN_4450-assinado.pdf	Documento de identificação	25073008173800000000144552446
Certidão	Certidão	25080616450937500000145241953
Certidão	Certidão	25080616543675100000145242936

Despacho	Decisão	25081918582080700000146317579
Petição	Petição	25082509101178000000146703282
Protocolo SISBAJUD	Certidão	25082514015969600000146759240
Intimação	Intimação	25081918582080700000146317579
Intimação	Intimação	25081918582080700000146317579
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	25092315514440500000149379664
download (12)	Alvará	25092315514447200000149379668
Intimação	Intimação	25092315514440500000149379664
Intimação	Intimação	25092315514440500000149379664
Peticao+protocolo+agravo+de+instrumento-assinado.pdf	Petição	25092416081000000000149492775
CERTIDAO+DE+PROTOCOLO+AI-assinado.pdf	Documento de identificação	25092416081100000000149492776

ENDEREÇOS:

RITA GOMES DE SOUZA SANDES
RD BR 230, 49, centro, SãO DOMINGOS DO AZEITãO - MA - CEP: 65888-000

ESTADO DO MARANHAO

Telefone(s): (98)3333-3333 - (98)3214-1718 - (98)3235-1244 - (98)2222-2222 - (98)3217-2562 - (98)3235-6767 - (98)3231-1880 - (99)98857-0866 - (98)3232-9784 - (98)2108-6300 - (98)2222-2221 - (98)98182-1194 - (98)2123-7049 - (11)1111-1111 - (98)3131-4103 - (98)98859-8220 - (99)2108-9235 - (98)2108-9235 - (98)3235-6787 - (98)3214-1723 - (98)9232-5050 - (98)3235-4100 - (98)3232-9789 - (98)8403-4577 - (98)3198-5500 - (98)9840-3225 - (98)9881-6456 - (98)8403-2259 - (99)8111-7532 - (98)3214-1700 - (98)3218-8700 - (98)3235-6185 - (98)6566-4552 - (98)3226-0000 - (00)0000-0000 - (98)9983-4752 - (98)9988-2911 - (98)8347-5276 - (86)9960-8404 - (98)3218-8411 - (98)3219-5000 - (98)9997-2351 - (98)3219-9700 - (98)2108-9000 - (98)3194-7700 - (98)0012-5412 - (98)3024-5597 - (98)3235-6146 - (98)3040-2051 - (98)9100-6166 - (98)8896-8815 - (98)3210-3218